



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : هاله سلامه عبد الغفار غديرى

العنوان : +

الحى / المدينة : المطريه

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستماره : 09-10-2026

رقم البطاقة : 26906010105169 رقم التليفون : 01129213984

العمر (تاريخ الميلاد) : 01-06-1969 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي

التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه

التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني

الاسم: د/ندى حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة: -----

الوظيفة: -----

الوظيفة: -----

التوقيع: -----

التوقيع: -----

التوقيع: -----

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----

خطة العلاج : -----

المستشفى : -----

قسم : -----

جهة العلاج : -----

نفقات : -----

ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: هاله سلامة عبد الغفار غدري National ID: 26906010105169	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



DMS
Kasir
فيلس





Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : خديجة عبد الله محمد علي

Sex:

3- Medical number:

Female

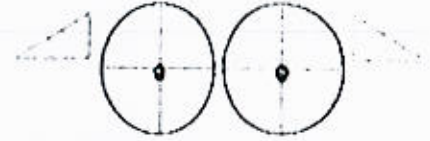
83126302

Old Med:

907/2020

2-ID number: 2600303002263

Patient Age: 63 Y



Family history

Phone

01143242203

BMI

REASON OF MDT

REMDT

marital status

NRS Score

GROUP

Date of MDT

02/21/2023

Co morbidity

HTN ON TTT
OPHRECTMY
HYSTRCTMY
LT MRM

Menopausal
status

POSTMENOPAUSAL

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

BX:

IDC

ER:

7/8

PR:

0/8

Her 2 Neu :

3

SISH :

Ki67 :

70

LT GII 3/2020

T

N

M

Sonomammography

PATIENT HISTORY

LT BREAST CANCER,,,RECEIVED NACT 4AC+ 12 WK TAXOL+HERCEPTIN

HAD LT MRM 11/2020 ENDED ADJ HERCEPTIN+PORTH AND NOW UNDER ADJ FEMARA+PROLIA/6 MO

MDT OUTCOME & PLAN

to cont adj Femara - prolia

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

د. شريف حسنين
د. محمد شاهين

RADIOLOGY

د. الهادي عبد الله

SURGERY

PATHOLOGY

Psychiatric

Nutrition

Name: هاله سلامة عبدالغفار غديري		
MR. : 5781		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه FOR ZOMITA 4 MG AFTER LABS ARAMIDEX + SUPPORTIVE TTT FOR ZOMITA 4 MG ARAMIDEX for 3 months + SUPPORTIVE TTT (methyltechno+calcium twice daily + alfacalcidol + paracetamol) clinical pharmacy intervention : ptn didn't receive zometa bcz ca is low 1.06 prem left breast cancer ct3 n2 mo idc 2 er8/8 pr6/8 her23+ rec tchp on 17/10/2023 left mrm ypt1 ypn0/2 rec kadcyla port arimidex for zometa arimidex (pt has history of ll dvt pul embolism on anticoagulant) FOR ARIMIDEX + SUPPORTIVE *3MONTHS BSM 7/2026: NORMAL STUDY		
تحريرا في ,		
	الوقت :	التاريخ : 20-09-2026
		الطبيب المعالج : Rana Essam
يعتمد ,		

Pathology Report

Name: خديجة عبد ربه

Age: 60 years.

Clinical data: Left breast mass.

Specimen type: Tru cut biopsy.

Date: 7/3/2020

Lab. Number: 433

Hospital Number: /2020

Gross Description:

Five greyish white tissue cores; 1.3 cm long each, totally submitted.

Microscopic Examination:

Histopathological examination of sections prepared from the specimen received reveals an infiltrating malignant epithelial growth. The tumour is made up of groups and small sheets of pleomorphic hyperchromatic malignant ductal epithelial cells. Stromal desmoplasia is moderate. Cellular and nuclear atypia are moderate.

Diagnosis:

Left Breast mass, core biopsy;

Invasive duct carcinoma GH, for IPT; (ER, PR, Her2 & Ki67).

Prof. Dr. Gamal A. Aty

Prof. Dr. Essam Ayad



Immunohistochemistry report

Report Number: 15154

Female

المرأة

المرأة

13/03/2020 12:39

13/03/2020 12:39

13/03/2020 12:39

13/03/2020 12:39

13/03/2020 12:39

13/03/2020 12:39

13/03/2020 12:39

13/03/2020 12:39

Primary Sample

Paraffin Block

[Box]

ER, PR, Ki67 (ER&PR: Harvey scoring system - Ki67: CAP scoring system)

Comment

Technique

Sample received was treated by: - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody - CONFIRM progesterone receptor (PR) (IS2) Rabbit monoclonal primary antibody
Sample received was treated by: - VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody - streptavidin DAB
Sample received was treated by: - CONFIRM anti Ki67 (30-6) Rabbit monoclonal primary antibody

[Box]

ER and PR nuclear staining of 80% of tumour cells (core biopsy)
PR nuclear staining of tumour cells (core biopsy)
Ki67 nuclear staining over expression: strong continuous membrane staining of > 10% of tumour cells (core biopsy)
Ki67 nuclear staining of 80-70% of tumour cells (core biopsy)

Comment

Conclusion

ER

POSITIVE (SCORE 7/8)

PR NEGATIVE

HER2/NEU PROTEIN OVER-EXPRESSION POSITIVE (SCORE 3+)

Ki67 THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS 80-70% (CORE BIOPSY)

Comment

Pathologist

[Signature]

Lab Director: [Signature]

Date : 23/06/2024	Patient Name: Khadiga Abd Rabbo Abd Allah Ali
Age : 64 Year(s)	Exam : ultrasound ABDOMEN& PELVIS
Pat. ID: 10838	Medical ID: 907/2020

Name: khadiga abdraboo

Date: 23 June 2024

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- Enlarged in size (about 17 cm at the right MCL), smooth outline, bright echopattern.
- No intra hepatic biliary radicle dilatation.
- Portal vein is not dilated and patent.

Gall Bladder: -

- Average size , , normal wall thickness, no stones.,
- CBD is not dilated.

Spleen: -

- Mildly enlarged in size (About 13.5 cm), displaying homogenous echopattern.

Kidneys: -

- Are of normal size , site , well differentiated & with no gross stones or backpressure changes , no solid or cystic lesion.
- Para-aortic and pancreatic area: no gross lesion
- No ascites .

URINARY BLADDER: Normal filling. Normal wall thickness, no stones or diverticulae or solid lesion detected.

Uterus removed.

No adenxal mass or cyst.

Opinion:

Bright hepatomegaly.

Mild splenomegaly.

Signature Dr. Doaa Abdelaziz
23/06/2024 4:46 PM



Patient Name: Khadiga Abd Rabbo Abd Allah Ali	Date : 28/07/2024
Exam : MRI LUMBER SPINE	Age : 64 Year(s)
Medical ID: 907/2020	Pat. ID: 10838

MRI EXAMINATION OF THE LUMBO-SACRAL SPINE

Technique of examination:

- Sagittal T1 & T2 WIs
- Axial T2 WIs
- No IV contrast was given.

**** A reported case of breast cancer,**

MRI Findings:

- Straightened lumbar curve.
- Normal sagittal diameter of the bony lumbar spinal canal.
- Spondylodegenerative changes of the lumbar spine manifested by :-
 - Anterior marginal osteophytic lipping of the vertebral end plates
 - Diminished height and bright T2 signal intensity of the lower lumbar discs denoting their degeneration.
- L5/S1 diffuse posterior disc bulge is seen effacing the epidural fat and autting the theca and slightly encroaching upon related neural exit foramina.
- No definite marrow infiltrative lesions.
- Normal MRI appearance of the conus medullaris and cauda equina nerve roots.
- No pre-vertebral or para-vertebral signal abnormalities.

Opinion:

- ***Lumbar spondylodegenerative changes***
- ***L5/S1 diffuse posterior disc bulge.***

Dr. Alaa Ragab, M.Sc., FEBR

Signature Prof. Menna Tallah Hanafy
05:33 2024/08/12

Name : KHADIGA ABD RABO

Date : 26-02-2020

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS: -

Chest:

- Multiple confluent masses and nodules are seen at left breast measuring about 5 x 4.3 cm as overall mass, associated with overlying skin thickening and nipple retraction.
- Multiple enlarged left axillary pathological lymph nodes are noted, the largest one measures about 4.5 x 2.5 cm.
- Three millimetric pulmonary nodules are seen at right lung 2 are calcified ranging from 3-5 mm and other smaller 2 mm non calcified nodule seen at superior segment of right lower lobe.
- Few millimetric pre-vascular lymph nodes are noted.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Tiny left thyroid lobe millimetric nodules.
- Small hiatus hernia is noted.
- Left hypochondrial sub-cutaneous lipoma is noted measuring 5.5X3.6 cm.

Abdomen:

- The liver is enlarged in size with homogenous low CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys. Tiny left mid calyceal stone is seen measuring about 3 mm.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Reviewing skeletal parts revealed tiny sclerotic foci seen at D2 & L5 vertebral bodies likely bone islands.

OPINION:

- **Left breast masses with left axillary lymphadenopathy.**
- **Few right pulmonary benign looking pulmonary micro-nodules.**
- **Fatty hepatomegaly with no focal lesions.**

Dr. Ibrahim Elsedawy.M.Sc

Dr. Amr Farouk.MD



Ministry of health
Central health laboratories
Pathology department

ImmunohistoChemistry report

Report Number: m1648

Female	النوع	خديجة خديجة عبدالله	اسم المريض
القاهرة	العنوان	60 Y	العمر
16/03/2020 12:39	تاريخ استلام العينة		تاريخ أخذ العينة
31/03/2020 10:34	تاريخ التقرير	مركز أورام دار السلام	مستشفى التحليل
		مركز أورام دار السلام	عنوان

Primary Sample :

Ceratin Block

Test :

ER & PR & HER2 neu & Ki67 (ER&PR: Harvey scoring system -Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

sample recieved was treated by : - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody / - CONFIRM anti-progesterone receptor (PR) (IE2) Rabbit monoclonal primary antibody.

Sample recieved was treated by : - VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using IAE Detection kit in ventana benchmark GX.

Sample recieved was treated by : - CONFIRM anti Ki67 (30-9) Rabbit monoclonal primary antibody.

Result :

ER: moderate nuclear staining of 80 % of tumour cells (core biopsy)

PR: NO nuclear staining of tumour cells (core biopsy)

HER2/neu protein over expression : strong continuous membrane staining of > 10 % of tumor cells (core biopsy)

Ki67 : positive nuclear staining of 60 - 70 % of tumour cells (core biopsy)

Referral Lab :

Comment :

Conclusion :

ER: POSITIVE (SCORE 7 / 8)

PR: NEGATIVE

HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : POSITIVE (SCORE 3+)

#Ki67: THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS 60 - 70 % .

(CORE BIOPSY)

Pathologist:

د/أيناس رمزي

Lab Director: د/تريزا ماهر

